

全院智能体运行管理情况报告

统计范围:全院(含分院区)

统计周期:2026 年 1 月 1 日 — 2026 年 6 月 30 日

编制单位:信息科

编制日期:2026 年 7 月

目录

- | | |
|--------------------|----------|
| 一、全院智能体总体建设情况(已编辑) | 四、运行监测情况 |
| 二、医院资源管理情况 | 五、报告总结 |
| 三、准入评测情况 | 附:编制说明 |

(在 Word 中右键点击此处,选择「更新域」自动生成目录。)

一、全院智能体总体建设情况

(一)总体规模与关键指标



口径:使用成本为统计周期内智能体所耗费的算力、许可、运维等各类成本之和;正常运行率=状态非异常、禁用的智能体数量÷总数。

截至 2026 年 6 月 30 日,全院累计纳管智能体 42 个,覆盖 54 个科室,科室覆盖率 68.4%;统计周期内总调用量 126.8 万次,正常运行率 95.2%,使用成本合计 38.6 万元。全院智能体应用规模持续扩大,运行总体平稳。

截至 2026 年 6 月 30 日,全院累计纳管智能体 42 个,覆盖 54 个科室,科室覆盖率 68.4%;统计周期内总调用量 126.8 万次,正常运行率 95.2%,使用成本合计 38.6 万元。全院智能体应用规模持续扩大,运行总体平稳。

(二)调用量趋势

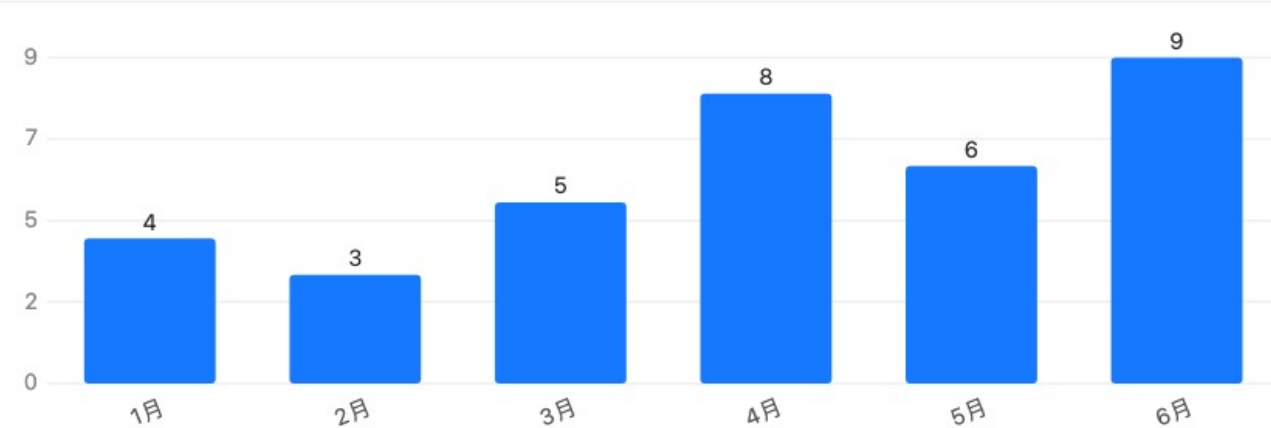
图 1-1 全院智能体月度调用量趋势(万次)



统计周期内月度调用量由 1 月的 14.2 万次增长至 6 月的 28.8 万次,累计增长 102.8%,月均环比增长 15.2%,反映智能体应用已逐步融入日常诊疗与管理流程。

(三)纳管智能体数量趋势

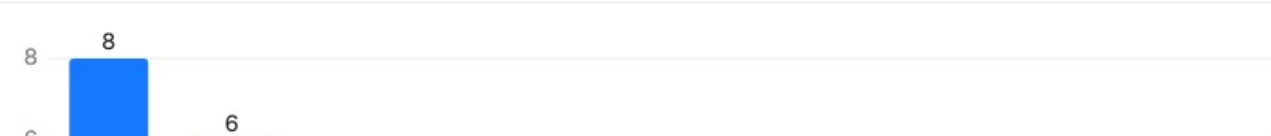
图 1-2 每月新增纳管智能体数量(个)

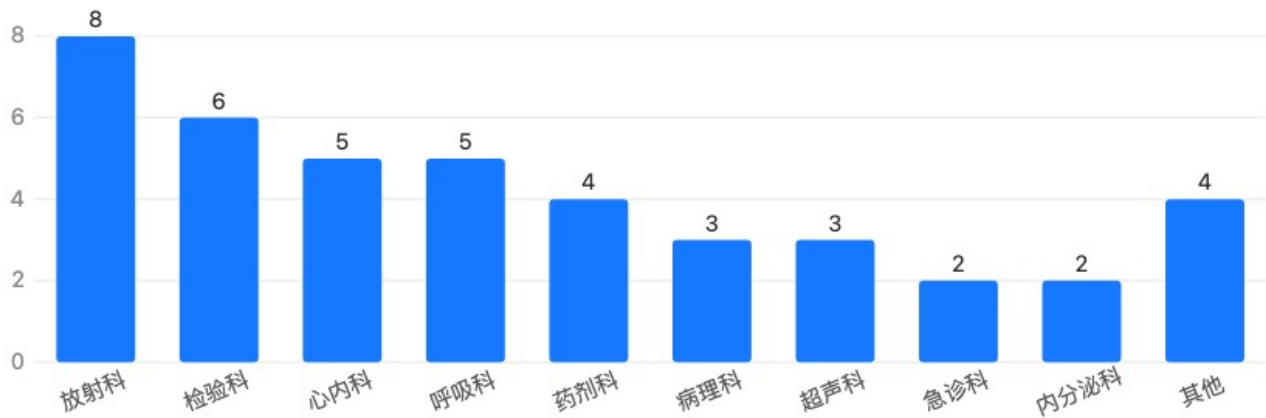


上半年累计新增纳管智能体 35 个,其中 4 月、6 月为接入高峰,分别新增 8 个、9 个,主要来自影像、检验等医技科室的批量接入。

(四)科室分布情况

图 1-3 智能体科室分布(左:数量;右:占比)





智能体主要集中于放射科(8 个)、检验科(6 个)等医技科室,合计占比 33.3%;心内科、呼吸科等临床科室各 5 个。全院尚有 25 个科室未接入智能体,临床科室覆盖率仍有提升空间。

(五)诊疗环节分布情况

图 1-4 智能体诊疗环节分布(占比)

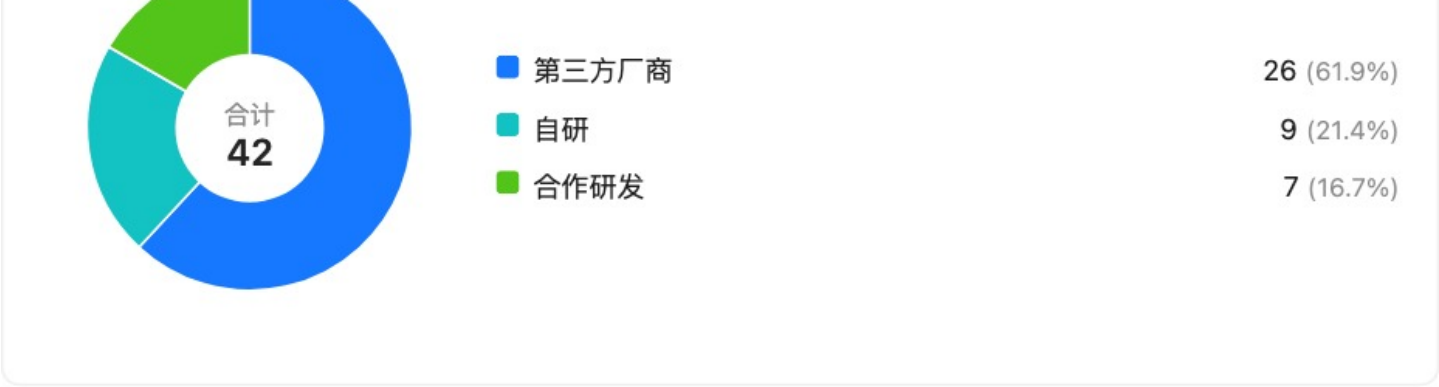


按诊疗环节划分,辅助诊断类智能体最多(10 个,占 24%),其次为辅助检查类(7 个,占 17%)与辅助治疗类(5 个,占 12%);导诊分诊、预问诊、预约挂号等诊前环节合计 9 个(占 21%)。手术辅助环节智能体仅 2 个,可结合外科手术管理需求适度补强。

(六)来源分布情况

图 1-5 智能体来源分布(左:数量;右:占比)





第三方厂商产品 26 个(占 62%)、自研 9 个(占 21%)、合作研发 7 个(占 17%)。第三方产品占比较高,建议持续加强供应商服务质量考核与交付验收管理,同时培育院内自研能力。

(七)风险分级情况

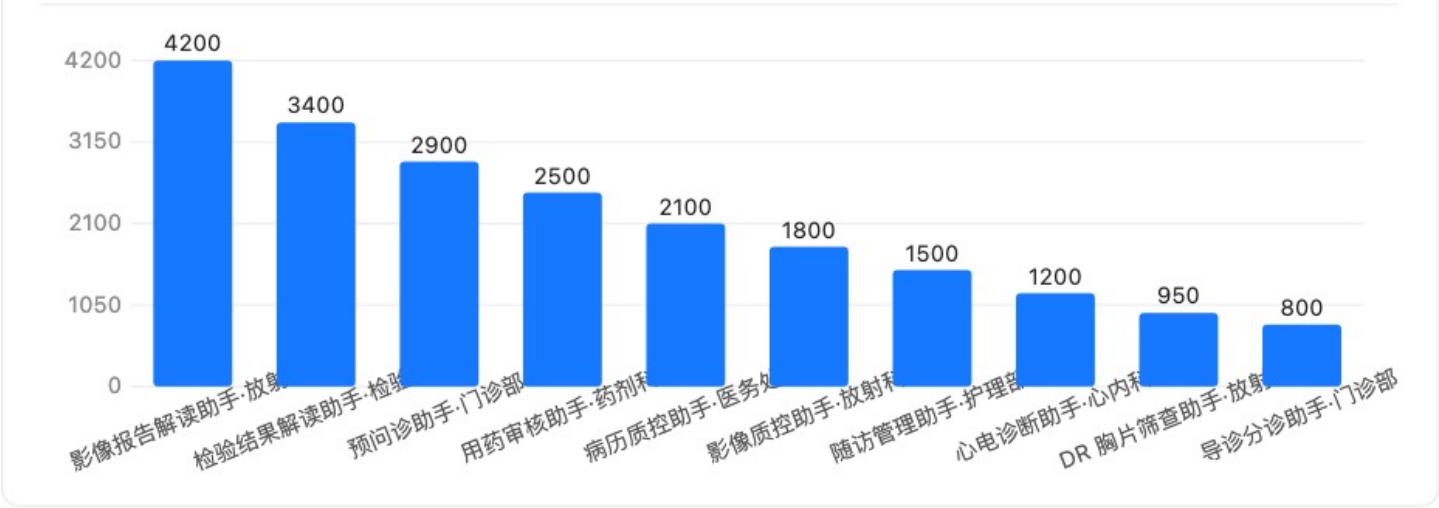
图 1-6 智能体风险分级分布(左:数量;右:占比)



按平台风险分级管理办法,高度关注类智能体 5 个(占 12%),均为直接参与临床决策类,已全部落实输出内容人工复核机制;中度关注类 14 个(占 33%)、一般关注类 23 个(占 55%)。本期无风险等级上调事项。

(八)高频调用智能体排行(TOP10)

图 1-7 高频调用智能体 TOP10(日均调用次数,标注所属科室)



影像报告解读助手(放射科)以日均 4200 次居首,检验结果解读助手(检验科)、预问诊助手(门诊部)分

影像报告解读助手(放射科)以日均 4200 次居首,检验结果解读助手(检验科)、预问诊助手(门诊部)分列第二、三位。TOP10 智能体日均调用量合计占全院总调用量的 71%,头部集中效应明显,建议对高频智能体优先保障算力资源并加密质量抽检频次。

二、医院资源管理情况

(一)对接业务系统总量

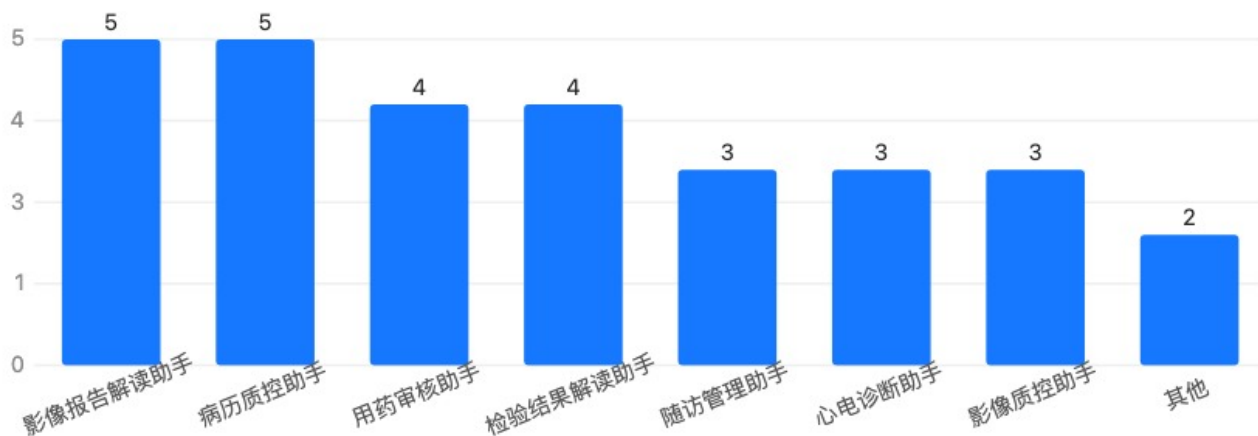
医院资源管理中心对接业务系统数量(个)

12

医院资源管理中心已对接 HIS、EMR、LIS、PACS、手麻、病案等 12 个业务系统,为智能体提供统一的数据与服务接入通道。

(二)各智能体对接系统数量排行

图 2-1 各智能体对接业务系统数量排行(个)



影像报告解读助手与病历质控助手各对接 5 个业务系统,为对接复杂度最高的智能体;对接 3 个及以上系统的智能体共 7 个,此类智能体接口依赖多,须重点纳入接口变更影响评估范围。

(三)各智能体对接系统具体情况

图 2-2 智能体×业务系统对接矩阵

HIS

EMR

LIS

PACS

手麻



从对接矩阵看,HIS 为全部智能体的基础依赖系统,EMR 次之(7 个智能体对接);手麻、病案等专科系统对接集中于少数智能体。

三、准入评测情况

(一)评测进度

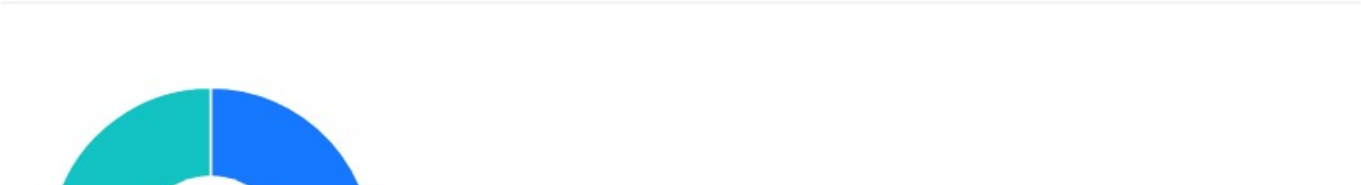
图 3-1 准入评测进度分布(项)



累计发起准入评测 42 项,其中已完成 30 项、评测中 7 项、待评测 5 项,完成率 71.4%;平均评测周期 2 天,较上期缩短 0.5 天。

(二)评测结果

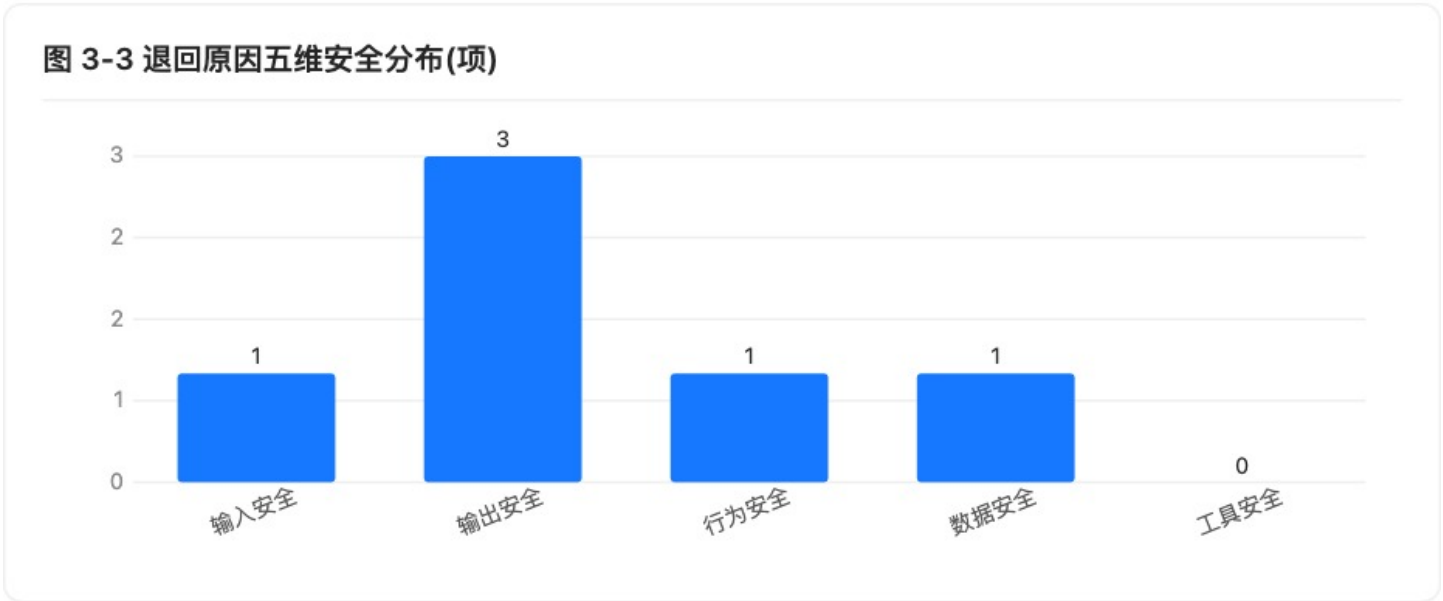
图 3-2 评测结果占比





已完成评测 30 项中,准入通过 24 项(80%)、退回修改 6 项(20%),通过率环比提升 5 个百分点。

(三)退回原因分析



对 6 项退回修改按输入安全、输出安全、行为安全、数据安全、工具安全五个维度归类:输出安全问题最多(3 项),主要表现为医学内容准确率不达标与不当表述;输入安全、行为安全、数据安全各 1 项;工具安全维度表现最好,未发现问题。建议针对输出安全维度,在供应商接入前增加预评测环节,并强化医学知识库对齐要求。

四、运行监测情况

(一)告警情况



口径:告警为智能体接入运行后产生的告警次数(较轻);故障平均恢复时间为运行状态异常的智能体恢复正常的平均耗时。

口径:告警为智能体接入运行后产生的告警次数(较轻),故障平均恢复时间为运行状态异常的智能体恢复正常的平均耗时。

图 4-1 告警次数周度趋势(近 12 个周期,次)



近 12 周累计产生告警 68 次,周均 5.7 次,整体呈波动下降趋势;峰值出现在第 1 周(8 次),与月初调用高峰重合。统计周期内发生故障 3 次,故障平均恢复时间 42 分钟,均在应急预案时限内完成处置。

(二)异常智能体情况说明

截至报告导出时,全院有 2 个智能体运行状态为异常:一是××检验结果解读助手,因 LIS 接口网关超时导致响应失败,正在实施接口扩容,预计××日恢复;二是××随访管理助手,因供应商模型服务升级临时停用,已按变更流程报备,预计××日恢复。异常期间相关业务均已切换至人工流程,未对临床工作造成影响。

(三)故障原因统计

表 4-1 故障与告警原因维度统计

维度(已编辑)	故障/告警次数	占比	主要成因分析
业务监控	31	43.7%	高峰时段接口调用超时、返回结果超出预期格式
状态监控	22	31.0%	模型服务响应缓慢、服务短时不可用
成本监控	10	14.1%	个别智能体调用量突增导致算力成本超出预算阈值
安全监控	8	11.2%	输出内容触发敏感词拦截、异常频次访问

故障与告警主要集中于业务监控与状态监控维度(合计 74.7%),成因均与高峰期算力与接口资源紧张相关;成本监控告警提示部分智能体调用增长快于预算,需同步优化配额管理。

(四)典型问题及处理方案

表 4-2 典型问题清单与处理进展

(四)典型问题及处理方案

表 4-2 典型问题清单与处理进展

序号	典型问题	影响范围	处理方案	处理进展	责任方
1	影像报告解读助手高峰期响应超时	放射科	接口网关扩容,错峰调度	已完成	信息中心
2	用药审核助手对罕见病用药提示不准确	药剂科	补充语料复测,上线前人工复核	进行中	供应商
3	随访管理助手消息推送重复	护理部	修复推送去重逻辑并回归测试	已完成	供应商

本期典型问题 3 项,2 项已闭环、1 项处理中;未闭环事项已列入下期重点跟踪清单。

五、报告总结

(一)存在的问题

- 一是科室覆盖不均衡。智能体集中于医技科室,临床科室与护理单元覆盖率偏低,全院仍有 25 个科室未接入。
- 二是评测退回率仍处较高水平。准入评测退回率达 20%,问题集中于输出安全维度,供应商交付质量参差不齐。
- 三是高峰期资源保障不足。业务与状态监报告警合计占 74.7%,均与高峰时段算力、接口资源紧张相关,LIS 接口异常尚未完全闭环。
- 四是成本增长需要关注。部分高频智能体调用量增长快于预算安排,成本监报告警 10 次,配额与预算机制有待完善。

(二)下一步工作建议

- 一是制定临床科室智能体接入推广计划,结合科室需求优先推进未覆盖科室的场景落地,力争年底科室覆盖率达到 80%。
- 二是建立供应商预评测机制,将输出安全指标纳入合同验收条款与供应商考核,从源头降低评测退回率。
- 三是实施算力与接口资源扩容,完成接口网关扩容与 LIS 接口专项治理,对 TOP10 高频智能体实行资源优先保障。

三是实施算力与接口资源扩容,完成接口网关扩容与 LIS 接口专项治理,对 TOP10 高频智能体实行资源优先保障。

四是完善成本配额管理,按智能体设定调用与成本预算阈值,超限自动预警并纳入月度运营分析。

附:编制说明

- ① 本报告由智能体管理平台基于台账聚合数据一键生成,统计口径统一,统计周期与筛选范围(科室/时间)见封面。
- ② 各模块图表由系统按实时数据自动生成,本模板内全部数据与图表均为示例;比率类指标在图表处注明分子分母口径。
- ③ 各模块文字综述由智能助手自动生成初稿,管理员可在平台编辑页在线调整后发布。

××××医院信息科
2026 年 7 月×日